



Consentimiento Informado para Colonoscopia o Endoscopia Digestiva Baja

Nombre paciente _____

Fecha _____ N° Ficha (RUT) _____ - _____

1. Declaro antes de formular mi consentimiento, que he sido informado sobre la naturaleza de mi enfermedad, su pronóstico y los eventuales daños que ésta produce a sus portadores; sobre las diferentes alternativas de tratamiento clínico que posee la ciencia médica y sobre los beneficios y eventuales riesgos que cada una de ellas conllevan.

2. Declaro además, que he sido informado y se me ha explicado en detalle sobre la naturaleza y fines de la(s) intervención(es) quirúrgica(s) y/o procedimiento(s) a ejecutar, sobre sus alternativas de tratamiento, sobre sus molestias probables, y sobre sus riesgos, daños propios, complicaciones y consecuencias más frecuentes que da cuenta la literatura y la práctica médica. Declaro además que la información antes mencionada, que es actualizada regularmente de acuerdo al conocimiento científico, para cada uno de los procedimientos cuyo consentimiento he dado mediante este instrumento, es la que se agrega a continuación en Anexo Informativo para el paciente y su familia, el que forma parte integrante de este consentimiento. Se me ha informado también que, pese a no encontrarse detalladas en el referido Anexo, existen otras complicaciones posibles que pueden producirse en forma excepcional.

3. Asimismo declaro, que he sido informado sobre los riesgos que enfrento a consecuencia de mi estado previo de salud, de la cual he dado información completa y veraz, de mi edad y otras causas de análoga naturaleza las que acrecientan el riesgo de la(s) intervención(es) quirúrgica(s) y/o procedimiento(s) a ejecutar.

4. Por último declaro que he tenido tiempo suficiente para hacer todas las preguntas que he considerado necesarias para mi mejor comprensión y que he sido informado por el Dr.: _____ y tengo la facultad de revocar este consentimiento sin expresión de causa.

5. Por el presente instrumento, consciente de los riesgos y beneficios de la(s) intervención(es) quirúrgica(s) y/o procedimiento(s) a ejecutar, y habiendo sido informado que el médico responsable de esto es el Dr.: _____, lo autorizo a realizar el procedimiento señalado en el encabezado de este documento.

6. Lo autorizo además a ejecutar la(s) intervención(es) quirúrgica(s) y/o procedimientos complementarios que se deban realizar, dentro de la práctica médica generalmente aceptada y del estándar del establecimiento, en el evento de presentarse complicaciones en la ejecución de la intervención(es) quirúrgica(s) y/o procedimiento(s) autorizados, o con posterioridad, así como en caso de presentarse hallazgos imprevistos durante los mismos.

Firmante: Paciente ☐ Padre/Madre ☐ Apoderado ☐

Nombre del padre o apoderado (si no es el paciente quien firma): _____

RUT N° _____ - _____

Firma del paciente o apoderado

Médico Informante : _____

RUT N° _____ - _____

Firma médico informante

Anexo Informativo para el paciente y su familia

Descripción del procedimiento:

La colonoscopia consiste en la exploración del recto y del colon (intestino grueso) e incluso los últimos centímetros del intestino delgado. Se realiza con un tubo flexible que se introduce por el ano, que lleva un sistema de iluminación y una cámara. Sirve para el diagnóstico de enfermedades que afectan al intestino grueso así como para el tratamiento de algunas de ellas.

La exploración se realiza en una posición cómoda sobre el lado izquierdo, aunque puede ser conveniente cambiar de postura durante la misma. La duración de una colonoscopia es variable, pero en total suele ser de unos 30 a 45 minutos. Para que la tolere mejor se le administra un sedante y si es preciso un analgésico. También se puede realizar con sedación profunda o anestesia general.

Durante la exploración puede ser necesario extirpar pólipos, tomar biopsias, destruir lesiones mediante la aplicación de calor, gas argón o láser, dilatar zonas estrechas o colocar prótesis. En algunos casos puede no lograrse completar la exploración de todo el colon o ser aconsejable realizar más de una sesión.

Alternativas de tratamiento disponibles:

Una alternativa es un enema baritado. Este consiste en introducir un contraste por el ano y rellenar todo el colon. Sus resultados diagnósticos son menores y no permite la toma de biopsias ni la realización de tratamientos. Otra alternativa, para el diagnóstico, es la colonografía virtual mediante scanner. Esto puede ser necesario de forma complementaria en ciertas circunstancias o si la colonoscopia no ha sido completa. Para los tratamientos, la única alternativa a la endoscopia es una intervención quirúrgica, lo que implica mayores riesgos.

Proceso previsible durante y después del procedimiento:

El paso del endoscopio por el intestino provoca malestar y sensación de hinchazón. Puede haber momentos de dolor, de corta duración. Esto es debido al paso del endoscopio por las curvas del colon y por el aire introducido. Una vez finalizada la exploración, queda sensación de gases que pasa en poco tiempo. Puede verse alguna pequeña hebra de sangre en la primera deposición tras la exploración.

Riesgos del procedimiento:

Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos no se materializan, y la intervención no produce daños o efectos secundarios indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los riesgos que pueden aparecer en este proceso o intervención.

Riesgos Frecuentes:

La colonoscopia es una técnica muy segura. Las complicaciones suelen ser leves y sin repercusión alguna. Estas son:

1. Dolor abdominal
2. Sudoración
3. Hinchazón o distensión abdominal y reacciones no deseadas a la medicación administrada. La posibilidad de complicaciones es mayor cuando el endoscopio se emplea para aplicar tratamientos, como polipectomías o tomas de biopsias, dilataciones o colocación de prótesis.

**Riesgos Graves:**

Las complicaciones graves son poco frecuentes pero posibles. Entre ellas están:

1. Perforación o rotura del intestino.
2. Hemorragia.
3. Reacciones alérgicas medicamentosas graves o alteraciones cardiopulmonares. Excepcionalmente puede requerirse un tratamiento urgente o una intervención quirúrgica.

Otros derivados de su problema de salud, de su edad o condición personal (a completar por el médico):

.....

Otras informaciones de interés:

Alergias a medicamentos: Debe conocerse previamente si hay alergia a anestésicos o sedantes a fin de evitar su empleo si están contraindicados.

Enfermos con tratamiento antiagregante o anticoagulante: pueden tener más riesgo de hemorragia, sobre todo si se toman biopsias o con otras maniobras. Se deben tomar precauciones al respecto.

La insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia renal, el infarto agudo de miocardio reciente y las enfermedades inflamatorias intestinales graves incrementan el riesgo de complicaciones.

Realice correctamente la preparación, lo que facilitará la exploración, disminuirá las molestias y evitará tener que repetirla. Avise si padece posibles alergias a medicamentos. Notifique también con tiempo (al menos una semana antes) si toma algún medicamento anticoagulante o antiagregantes (Aspirina, Xarelto, Neosintrom u otros), ya que puede ser necesario suspenderlos antes.

Acuda acompañado. No conduzca vehículos durante el resto del día si se le ha administrado sedación.

A veces, durante la intervención, se producen hallazgos imprevistos. Pueden obligar a tener que modificar la forma de hacer la intervención y utilizar variantes de la misma no contempladas inicialmente.

A veces es necesario tomar muestras biológicas o biopsias para estudiar mejor su caso. Pueden ser conservadas y utilizadas posteriormente para realizar investigaciones relacionadas con la enfermedad que usted padece. No se usarán directamente para fines comerciales. También puede ser necesario documentar el caso clínico con imágenes (fotos o videos) para usarse con fines docentes de difusión del conocimiento científico. Su identidad siempre será preservada de forma confidencial.

RUT N° _____ - _____

Firma paciente